

호흡곤란을 주소로 내원한 환자의 흉부 X선이다
예측할 수 있는 신체검사 소견은? (30/85)



- 1) 좌폐 호흡음 감소
- 2) 우폐 수포음(crackles)
- 3) 좌폐 천명음(wheezing)
- 4) 우폐 타진 시 탁음(dullness)
- 5) 좌폐 기관지 호흡음 (bronchial bleeding sound)

- 폐결핵에 관련된 사항에서 틀린 것은? (67/85)
- ① Ghon complex는 결핵의 초기에서 볼 수 있는 소견임
- ② 고사를 광범위하게 보이는 육아종성 병변일 경우 환자의 면역상태가 나쁜 편임
- ③ 고사성 육아종성 병변이 관찰되면 결핵감염으로 확진 가능함
- ④ 환자의 면역이 저하된 경우 속립성 결핵(miliary tuberculosis) 양상을 보임
- ⑤ 결핵 결절이 오래될 경우 섬유성 또는 석회화 결절로 존재함

- 폐원발 선암종을 진단하는데 도움을 주는 면역조직화학염색 마커는? (66/85)

- ① EGFR, p16, p40
- ② CK7, TTF-1, Napsin A
- ③ EMA, CK5/6, D2-40
- ④ p63, p40, CK7
- ⑤ Chromogranin, CD56, synaptophysin

- 전이성 폐암종의 진단에 도움을 주는 기술 중 틀린 사항은? (59/85)

- ① 양측 폐에 종양성 결절을 관찰할 수 있음.
- ② 늑막하 및 기관지혈관 주위의 림프관 내에 종양조직을 볼 수 있음
- ③ **상피내 암종 소견을 볼 수 있음**
- ④ 종양세포에 CDX2, PAX8, CK19 등 마커에 면역발현을 함
- ⑤ 종양 결절이 다수 관찰될 때 속립성 결핵과 감별이 필요함

- 55세 남자가 한 달 전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 마른기침이 있었고 열은 없었다. 평소 특별한 질환은 앓고 있지 않았다. 직업은 학교 선생님이었고 비흡연자이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 24회/분, 체온 36.5°C 였다. 양쪽 가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈액 검사, 폐기능 검사 결과와 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 다음으로 시행할 검사는? (66/85)

혈액검사

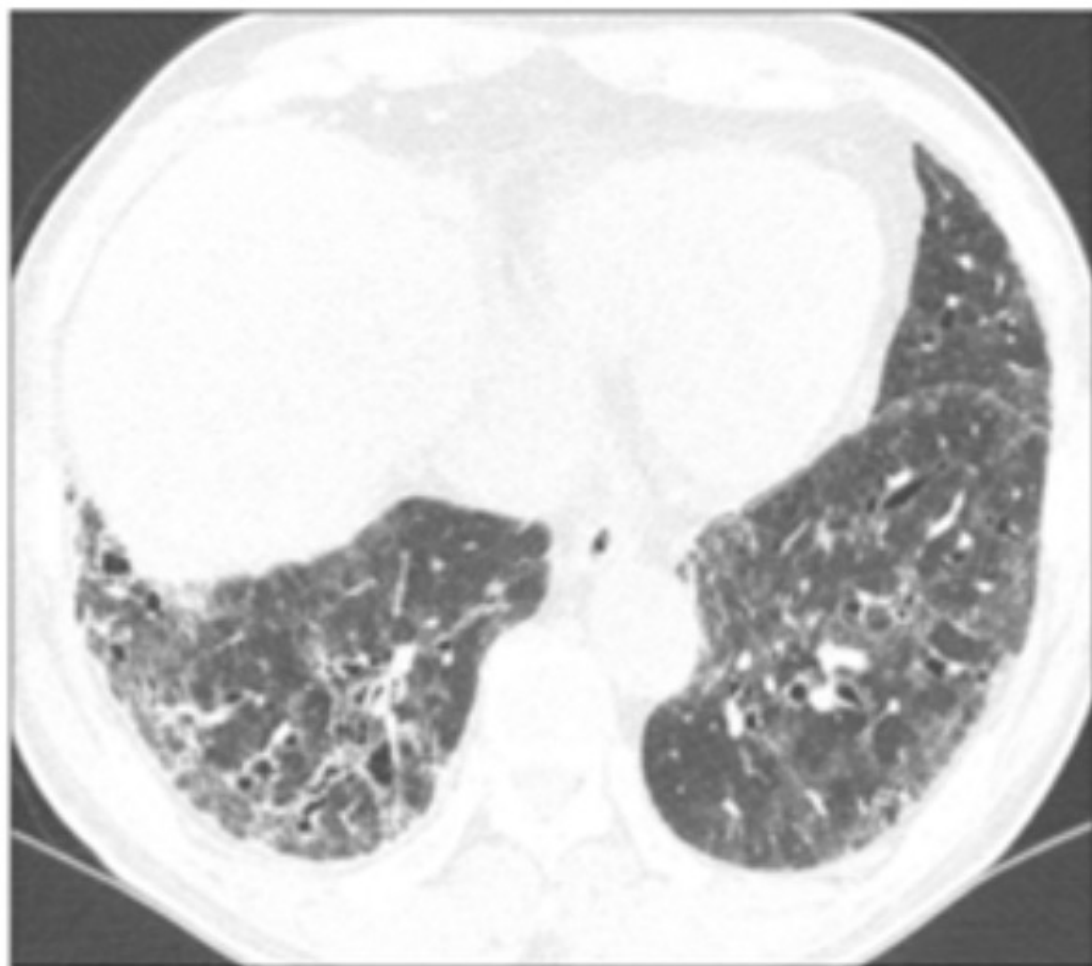
백혈구 9,000/mm³ (중성구 30%, 림프구 68%, 호산구 2%), 혈색소 13.2 g/dL,

혈소판 350,000/mm³

폐기능검사

강제폐활량(FVC) 정상예측치의 70%, 1초간 강제날숨량(FEV1) 정상예측치의 88%,

1초간 강제날숨량/강제폐활량(FEV1/FVC) 84%



- ① 심초음파
- ② 가래 그람염색
- ③ 환기/관류 스캔
- ④ 가는바늘흡인검사
- ⑤ 비디오보조흉강경 폐생검

- 다음 중에서 성인호흡곤란증후군(ARDS)에 가장 합당한 흉부 영상은? (66/85)

①



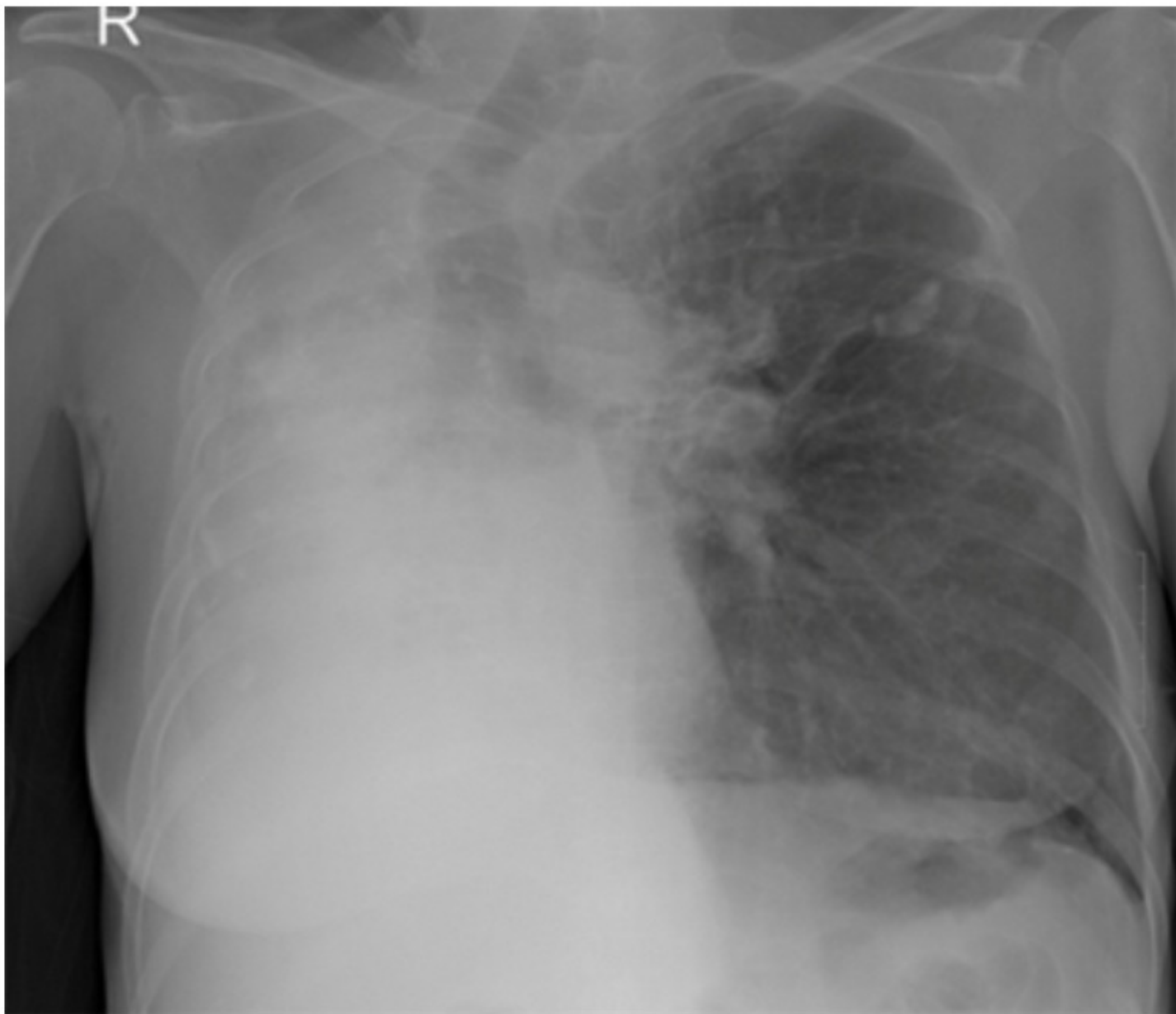
②



③



④



5



- 급성호흡곤란증후군(ARDS) 환자에서 1회 환기량을 이상체중의 10ml/Kg로 할 경우 과팽창이 가장 잘 일어날 수 있는 곳은? (49/85)

- ① 정상 폐포
- ② 무기폐가 있는 곳의 폐포
- ③ 폐부종이 있는 곳의 폐포
- ④ 양측 폐 위쪽에 있는 폐포
- ⑤ 양측 폐 아래쪽에 있는 폐포

- Obstructive sleep apnea에서 심장질환을 일으키는 기전으로 제시되는 것은? (60/85)

- ① 코결이
- ② 저산소혈증
- ③ 교감신경계 자극
- ④ 수면 조각화(sleepfragmentation)
- ⑤ 호흡 불안정(ventilatoryinstability)

- 폐쇄성수면무호흡(Obstructivesleep apnea)의 치료로 최근에 시도되고 있는 방법으로 전기적으로 자극해서 좋은 효과를 얻은 방법에서 자극한 신경은? (33/85)

- ① 미주신경(vagus nerve)
- ② 더부신경(accessarynerve)
- ③ 가로막신경(phrenicnerve)
- ④ **혀밑신경(hypoglossalnerve)**
- ⑤ 갈비사이신경(intercostalnerve)

- 62세 여자가 5일 전부터 왼쪽 가슴이 아프고 숨이 차다고 내원하였다. 기침, 가래, 발열은 없었다고 하였다. Vital sign들은 정상이었다. 과거 3년 전에 결장암을 진단받은 적이 있다고 한다. CT검사는 다음과 같다. 진단은? (56/85)



- 62세 여자가 5일 전부터 왼쪽 가슴이 아프고 숨이 차다고 내원하였다. 기침, 가래, 발열은 없었다고 하였다. Vital sign들은 정상이었다. 과거 3년 전에 결장암을 진단받은 적이 있다고 한다. CT검사는 다음과 같다. 진단은? (56/85)

- ① 중피종
- ② 결핵가슴막염
- ③ 악성가슴막삼출
- ④ 국한성 섬유종양
- ⑤ 부폐렴가슴막삼출

- 횡경막 근력을 가장 잘 반영하는 지표? (67/85)

- ① peak cough flow
- ② forced vital capacity
- ③ maximal expiratory pressure
- ④ maximal insufflation capacity
- ⑤ maximal inspiratory pressure

- 가래 배출에 도움을 주는 도구와 거리가 먼 것은?
(38/85)

Threshold PEP



Turboforte(Flutter)



CoughAssist



Vest(portable high-frequency chest wall oscillation system)



Therapep



- 영상학에서 소위 GGO(Ground Glass Opacity) 음영과 폐암과의 관계를 올바르게 기술한 사항은? (59/85)

- ① 3cm 이상의 타원형 병변
- ② 병변경계가 깨끗하다
- ③ 병변이 3개월 이상 지속
- ④ 크기의 변화는 없는 것이 특징
- ⑤ 조직검사나 절제수술은 필요 없다.

- 생후 1주일때 기관식도로 수술을 받은 병력이 있는 3세 환아가 심한 기침을 주소로 응급실을 내원하였다. 입원당시 혈압 100/60mmHg, 맥박 120/분, 호흡수 30/분, 체온 37도, 산소포화도는 92% 였다. 환자의 흉부사진은 아래와 같았다. 즉각적인 조치로 가장 합당한 것은? (67/85)

- ① 흉관삽관
- ② 기관삽관
- ③ 흉부천자
- ④ NG(nasogastric)관 삽입
- ⑤ 목부위 피부 및 피하층 절개

Idx 324
SOMATOM Definition Flash
Se 4
Im 38
CT
FFS
2.0thk
0.0
AWJ VI

DOB:2013-02-28

LAH

FOV 247X421
TP 0.0
TI 285
kVp 100.0
mAs 36(337 mA)
GT 0
Thorax^05_Flash_Thorax (Adult)
HR 2.0 MPa
2016-11-12/16:28:01



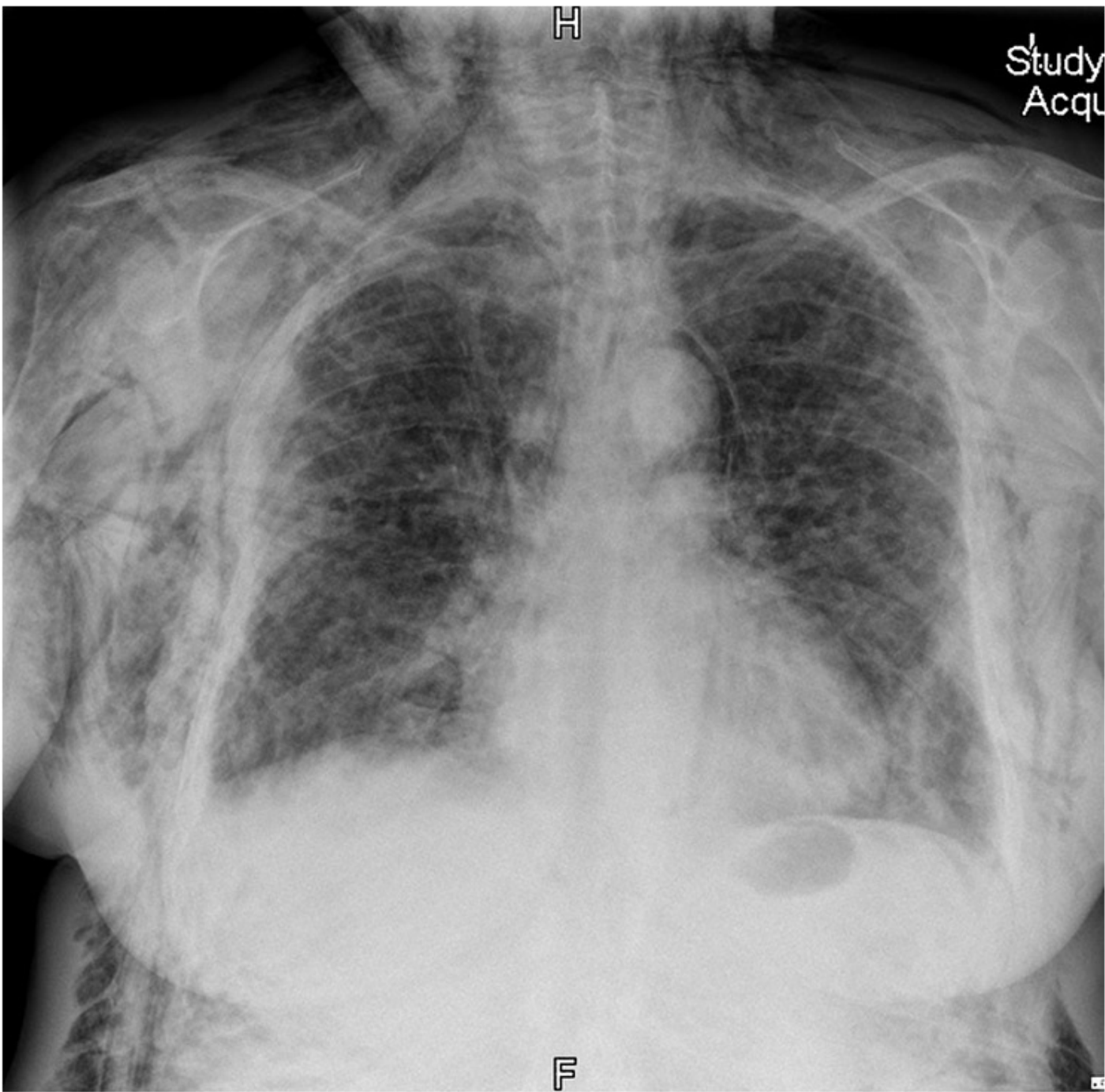
W 1500

L -700

Z 100%

Compression 2:1

50mm



- 생후 1주일때 기관식도루 수술을 받은 병력이 있는 3세 환아가 심한 기침을 주소로 응급실을 내원하였다. 입원당시 혈압 100/60mmHg, 맥박 120/분, 호흡수 30/분, 체온 37도, 산소포화도는 92% 였다. 환자의 흉부사진은 아래와 같았다. 즉각적인 조치로 가장 합당한 것은? (67/85)

- ① 흉관삽관
- ② 기관삽관
- ③ 흉부천자
- ④ NG(nasogastric)관 삽입
- ⑤ 목부위 피부 및 피하층 절개

- 50세 남자가 3일 전부터 왼쪽 가슴이 아파 병원에 왔다. 1주일 전부터 기침, 가래와 함께 발열, 오한이 있었다. 2일 전부터는 숨을 들이쉬는 때 왼쪽 가슴에 통증이 생겼다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 92회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.3°C 였다. 가슴 청진에서 왼쪽 호흡음이 감소되었다. 검사 결과는 다음과 같았다. 세프트리악손(ceftriaxone)과 클린다마이신 (clindamycin)으로 치료를 시작하였다. 추가 치료는? (58/85)

혈액: 혈색소 13.2 g/dL, 백혈구 11,300/mm³ 혈소판 350,000/mm³, 단백질 6.6 g/dL, 포도당 102 mg/dL 젖산탈수소효소 430 U/L (참고치, 115 ~ 220)

가슴막삼출액: pH 6.7, 백혈구 12,100/mm³ (중성구 81%, 림프구 19%) 단백질 4.1 g/dL, 포도당 25 mg/dL 젖산탈수소효소 1,100 U/L 아데노신탈아미노효소(ADA) 45 IU/L 암배아항원 1.4 ng/mL

- 50세 남자가 3일 전부터 왼쪽 가슴이 아파 병원에 왔다. 1주일 전부터 기침, 가래와 함께 발열, 오한이 있었다. 2일 전부터는 숨을 들이쉴 때 왼쪽 가슴에 통증이 생겼다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 92회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.3°C 였다. 가슴 청진에서 왼쪽 호흡음이 감소되었다. 검사 결과는 다음과 같았다. 세프트리악손(ceftriaxone)과 클린다마이신 (clindamycin)으로 치료를 시작하였다. 추가 치료는? (58/85)

- ① 항결핵제
- ② 가슴관삽입
- ③ 가슴막유착술
- ④ 겔질제거(decortication)
- ⑤ 반코마이신(vancomycin)

- 70세 남자가 2주 전부터 숨이 차서 병원에 왔다. 기침, 가래는 없었고, 1개월 전부터 식욕이 떨어져 식사를 잘 못 했고 체중이 4 kg 정도 줄었다고 하였다. 50갑·년의 흡연자였다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 92회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.0°C 였다. 왼쪽 가슴 청진에서 호흡음이 들리지 않았다. 가슴 x선 사진이다. 진단은? (55/85)

- ① 폐렴
- ② 무기폐
- ③ 가슴막삼출
- ④ 기관지확장증
- ⑤ 왼쪽 주기관지 막힘

